

①

細胞障害性抗がん薬:薬剤師の実践ポイント

累積投与量管理と副作用の早期発見

1 服薬指導で伝えるポイント



骨髄抑制の時期(nadir)を伝え、感染予防行動を具体的に指導する



制吐薬の予防的服用の重要性を、催吐リスク分類に応じて説明する



末梢神経障害・脱毛など、外見や感覚に関わる変化は事前に心構えを伝える

2 処方監査・疑義照会のタイミング

- ☐ アントラサイクリン系の累積投与量が上限に近づいていないか確認する
- ☐ イリノテカン使用患者でUGT1A1遺伝子多型検査の実施状況を確認する
- ☐ 腎機能・肝機能に応じた減量基準(シスプラチン、メトトレキサート等)が守られているか確認する

3 施設間連携・情報共有のポイント



累積投与量・投与歴をお薬手帳や診療情報提供書で継続的に共有する



心機能検査(心エコー等)のフォロー状況を医療機関間で確認する

4 実践チェックリスト

- ☐ 新規レジメン開始時に、薬剤分類ごとの重点モニタリング項目を薬歴に記録する
- ☐ 前回投与時の副作用の程度を必ず聴取し、次コースへの申し送りを意識する
- ☐ 減量・休薬の判断根拠(Grade、検査値)を処方箋・カルテ記載と照合する

細胞障害性抗がん薬の管理は「今回の一投与」ではなく「累積」の視点が欠かせない。投与歴を継続的に追う姿勢が、重篤な副作用の予防につながる。